到明显改善，且观察组主观睡眠质量、睡眠潜伏期、入睡时间、睡眠持续性、睡眠障碍、日间功能、安眠药物评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。提示温馨助产护理干预的实施有助于提升产妇睡眠质量。

综上所述，温馨助产护理干预用于分娩产妇中，有助于降低产后出血发生率，缩短产程、降低出血量，能提升产妇睡眠质量，可获得较高的护理满意度，值得临床应用。

参考文献

[1] 李慧芳. 预见性护理在阴道分娩产后出血预防工作中的效果分析[J]. 中国药物与临床,2020,20(2):149-151.
[2] AZA B, RKB C, JD A, et al. Early Use of Fibrinogen Replacement Therapy in Postpartum Hemorrhage-A Systematic Review[J]. Transfusion Medicine Reviews,2020,34(2):101-107.
[3] 金杏, 田演娇, 刘文娟, 等. 基于改良产后出血预测评分的分级护理联合AIDET沟通对高危产妇产后出血的预防作用[J]. 中国医药导报,2022,19(10):181-184.
[4] 谢妮, 周凌云, 王毅. 子宫动脉上行支结扎术在产后出血高危因素剖宫产术中的预防性应用效果[J]. 中国妇幼保健,2021,36(7):1464-1467.
[5] 梅彬彬, 张萍, 叶媛, 等. 职业获益感在助产士工作压力源和人文执业能力间的中介效应分析[J]. 中国实用护理杂志,2022,38(19):1483-1489.
[6] SHINOHARA S, OKUDA Y, HIRATA S, et al. Adenomyosis as a Potential Risk Factor for Adverse Pregnancy Outcomes:A Multicenter Case-Control Study[J]. The Tohoku Journal of Experimental Medicine,2020,251(3):231-239.
[7] 徐章云, 刘培. 预见性护理对阴道分娩产妇产后出血的临床预防效果观察[J]. 贵州医药,2021,45(12):2009-2010.
[8] 张增强. 卡前列素氨丁三醇在预防产后出血中的作用和对产妇血流动力学参数的影响[J]. 中国妇幼保健,2021,36(15):3464-3466.
[9] 梁秋霞, 翁廷松, 卢荔婕, 等. 产妇产后出血的危险因素分析及基于循证医学的预警信息系统构建[J]. 中国性科学,2021,30(6):80-84.
[10] 张泳.《妇产科护理学笔记(第四版)》出版: 评价综合护理干预在预防宫缩乏力性产后出血中的临床应用效果[J]. 介入放射学杂志,2021,30(5):10004-10004.
[11] ATIQ F, WUIJSTER E, MPMD MAAT, et al. Low Von Willebrand Factor: Cut-Off Value for Diagnosis and Risk Score to Predict Bleeding Incidence[J]. Blood,2020,136（Supplement 1）:18-19.
[12] 刘畅, 贾茹, 郑晓明, 等. 第二产程预防性使用葡萄糖酸钙在降低单胎初产妇产时及产后出血量的作用[J]. 国际妇产科学杂志,2020,47(2):195-198.
[13] 李艳霞, 王永霞, 张利荣. 基于高危因素评估表的针对性护理对初产妇产后出血的预防效果研究[J]. 山西医药杂志,2021,50(23):3324-3326.
[14] 张慧, 池樱. 横向环形缝合瘢痕子宫下段预防产后出血的应用价值研究[J]. 中国计划生育和妇产科,2020,12(8):39-40,48.
[15] 肖媛媛. 精细化护理对产妇心理状态, 睡眠状况及产后出血量的影响[J]. 检验医学与临床,2020,17(8):1044-1046,1050.
[16] 孙妮, 王海燕, 刘尧. 探讨第三产程使用气囊腹压带预防分娩镇痛产妇产后出血的临床效果[J]. 贵州医药,2020,44(12):1930-1931.
[17] 何美元, 雷鸽. 集束化护理干预联合常规护理对产后出血患者的应用效果及其对凝血因子的影响[J]. 血栓与止血学,2022,28(3):876-877.

阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的应用效果评价

周 斌[1*] 张佳佳[2]

（1. 威海市中心医院神经内科，山东 威海，264400；
2. 乳山市人民医院 ICU，山东 威海，264500）

摘 要：目的 探讨帕金森病合并言语障碍患者应用阶梯式言语康复护理的效果。**方法** 选择 2021 年 1 月—2022 年 2 月威海市中心医院收治的 72 例帕金森病合并言语障碍的患者作为研究对象，以随机数表法将患者分为对照组和观察组，每组 36 例。对照组应用常规护理干预，观察组应用阶梯式言语康复护理，持续护理 12 周后，比较两组患者的嗓音异常情况［嗓音障碍指数（VHI）］、言语功能［西方帕金森病评分量表（UPDRS）与言语清晰度评分］、护理满意度。**结果** 护理后，观察组患者 VHI 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。护理后，观察组患者的 UPDRS 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组患者的言语清晰度评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。观察组患者的护理满意度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 帕金森病合并言语障碍患者确诊疾病后实施阶梯式言语康复护理，可有效改善嗓音异常、言语功能，提高患者的满意度，值得临床应用。

关键词： 帕金森病；言语障碍；常规护理干预；阶梯式言语康复护理；言语清晰度；言语功能
中图分类号： R473.5 **文献标识码：** A **文章编号：** 1009-8011（2023）-14-0119-04

作者简介： 周斌（1990—），女，汉族，籍贯：山东省威海市，本科，主管护师，研究方向：神经内科护理。
* **通讯作者：** 周斌，E-mail：zb724856127@126.com。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

帕金森病属于神经退行性病变，全球有 1.5% 的人患有此病[1-2]。60 岁以上老年人是高发群体，伴随着年龄增长，发病率逐步升高[3-4]。言语障碍是常见的帕金森病合并症，有 50% ~ 90% 的帕金森病患者存在言语障碍，临床表现以声音嘶哑、发声不协调、语言表达清晰度下降等为主[5]。临床调查表明，对帕金森病合并言语障碍患者实施言语康复训练，可有效提高发音音量、改善音质状态，延长发音时间[6]。但部分患者年龄较大、体质较差、耐受性低，短时间内无法承受较大强度训练，训练依从性难以保障。阶梯式言语康复护理是一种针对性护理方案，包含基础康复及强化康复，要求结合患者言语功能现状，循序渐进地安排患者进行言语康复，保证患者可逐步耐受该训练，保证患者的训练依从性。本研究选择 2021 年 1 月—2022 年 2 月威海市中心医院收治的 72 例帕金森病合并言语障碍的患者作为研究对象，探讨阶梯式言语康复护理的效果，报道内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2021 年 1 月—2022 年 2 月威海市中心医院收治的 72 例帕金森病合并言语障碍的患者作为研究对象，以随机数表法将患者分为对照组和观察组，每组 36 例。观察组中，男性 21 例，女性 15 例；年龄 62 ~ 77 岁，平均年龄（69.72 ± 3.87）岁；病程 1 ~ 10 年，平均病程（5.71 ± 1.43）年；体质量 43 ~ 87 kg，平均体质量（65.39 ± 5.21）kg。对照组中，男性 22 例，女性 14 例；年龄 62 ~ 76 岁，平均年龄（69.45 ± 3.93）岁；病程 1 ~ 9 年，平均病程（5.41 ± 1.34）年；体质量 43 ~ 88 kg，平均体质量（65.69 ± 5.26）kg。两组患者的一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。本研究经威海市中心医院医学伦理委员会批准，并获得所有受试对象的知情同意。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：①符合《中国帕金森病治疗指南（第四版）》[7]、《中国帕金森病重复经颅磁刺激治疗指南》[8] 中帕金森病的临床诊断标准；②在医院完成头颅 CT 及 MRI 检查，影像学图像满足疾病诊断标准；③合并言语障碍；④具有良好的护理依从性；⑤全面配合医院完成护理、评价、分析。

排除标准：①因脑动脉硬化、药物中毒以及感染等因素诱发帕金森病患者；②合并胃食管反流、吞咽功能障碍等疾病患者；③精神状态及意识状态显示异常患者；④合并脑梗死、脑出血等严重颅脑疾病患者；⑤同时参与其他研究或近三月内参与类似研究患者。

1.3 方法

对照组采用常规护理干预。首先评价患者的言语障碍严重程度与特点，制订符合患者病情的言语康复训练方案，并和患者、家属做好沟通工作，方便训练方案落实到位。言语康复训练以口唇运动、呼吸控制、发声训练、音速控制、音量控制等为主，训练时间是 60 min/ 次，隔天进行训练 1 次，持续护理 12 周。

观察组采用阶梯式言语康复护理。（1）创建阶梯式言语康复护理小组：针对合并言语障碍的帕金森病患者，科室应创建阶梯式言语康复护理小组，护士长任组长，病房责任护士任普通组员。小组成立后，在主治医师指导、帮助下再次系统、完整、准确地学习帕金森病知识与言语障碍知识，明确帕金森病和言语障碍的相关性，针对这一类患者制订康复护理方案。明确阶梯式言语康复护理后，安排小组成员系统、集体学习该护理理念、护理方案，要求所有护士均掌握护理方案要求的护理技能，在临床高质量地提供相应护理服务。（2）功能评估：为保证护理的针对性、有效性，确诊言语障碍后即刻进行专业、全面的言语障碍分析，了解患者的言语功能，保证功能评估的全面性与完整性。基于评估结果，调整阶梯式言语康复护理的内容、强度、频率，保证护理的针对性，保证患者可耐受护理，能够配合护理干预。（3）基础康复：①晨间呼吸训练：指导患者在清晨进行呼吸训练，呼吸时间尽量控制在 2∶1，尽可能准确完成腹部呼吸，保证每一次的呼吸运动时间类似或相同，保证训练过程中的声音节奏及强度，结合患者病情转归情况逐步增加训练强度。②早餐后进行面部肌肉、面部表情训练：通过吹口哨、伸舌头、咀嚼、鼓起脸颊与吐舌头等多种动作，刺激面部神经及肌肉，促使面部神经与肌肉充分协调，增强面部敏感度。③午餐后进行唇舌训练：通过伸舌头、缩舌头，舌头在嘴唇上方进行环形运动达到训练目的。舌头伸出后，还需触摸患者两边的鼻子、下巴、嘴角，反复交替进行训练。④上述三种训练持续一周后开始进行语速、音量练习：尽量在镜子前完成训练，独立、有规律地完成相关训练，重点观察嘴巴变化，尽可能刺激面部肌肉，促进面部功能、言语功能改善。（4）强化康复：口形训练期间尽量延长发元音时间、扩大声音频率范围，选取日常生活中常用句子进行语音训练，持续训练 2 周后进一步加强训练强度，尤其是语言表达方面训练。首先进行一周单字、词语训练，之后进行单句、短话训练，再进行朗读训练，最后进行情景模拟对话训练。

1.4 观察指标

①嗓音异常：护理前后运用嗓音障碍指数（voice handicap index，VHI）[9] 进行评价，评价内容包含生理、功能及情感三部分，每部分评价问题共计 10 个，每个问题均通过五分法评价，最低分是 0 分，最高分是 4 分，通过评价嗓音异常对患者日常生活质量的影响达到评价目的，0 分代表不影响，1 分代表极少影响，2 分代表部分影响，3 分代表经常影响，4 分代表总是影响，每部分总分是 0 ~ 40 分，总分值是 0 ~ 120 分，分数越高影响越严重。②言语表达：护理前后运用西方帕金森病评分量表（unified parkinson disease rating scale，UPDRS）进行评价，评价指标的评分项共计 5 个等级，包含 0 分、1 分、2 分、3 分、4 分，分数越高言语障碍越严重[10]。③言语清晰度：护理前后运用言语清晰度字表法评价，量表中单字共计 200 个，结合汉语语音学理论、临床患者容易出现的异常语音设计而成[11]。④护理满意度：护理后运用威海市中心医院自

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制帕金森病合并言语障碍护理满意度调查问卷进行评价，问卷总分是 0 ~ 100 分，0 ~ 59 分代表患者不满意，60 ~ 89 分代表患者基本满意，90 ~ 100 分代表患者十分满意，护理满意度 =（十分满意 + 基本满意）例数 / 总例数 ×100%。

1.5 统计学分析

采用 SPSS 22.0 统计学软件进行研究数据处理，计量资料采用（$\bar{x} \pm s$）表示，组间比较采用独立样本 t 检验；计数资料采用 [n（%）] 表示，组间比较采用 x^2 检验。以 $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的嗓音异常评分比较

护理后，观察组患者的 VHI 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 1。

表 1 两组患者的嗓音异常评分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	生理		功能	
		护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	36	20.65 ± 4.18	16.04 ± 3.45*	22.72 ± 5.47	18.00 ± 4.21*
对照组	36	20.43 ± 4.13	18.16 ± 3.82*	22.99 ± 5.54	20.37 ± 4.89*
t		0.225	2.471	0.208	2.204
P		0.823	0.016	0.836	0.031

续表 1 两组患者的嗓音异常评分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	情感		总分	
		护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	36	25.94 ± 4.37	19.10 ± 3.68*	76.18 ± 8.43	53.10 ± 5.47*
对照组	36	25.76 ± 4.31	22.37 ± 3.97*	75.43 ± 8.35	60.25 ± 5.89*
t		0.176	3.624	0.379	5.337
P		0.861	0.001	0.706	<0.001

注：与同组护理前比较，*$P<0.05$。

2.2 两组患者的言语功能评分比较

护理后，观察组患者的 UPDRS 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组患者的言语清晰度评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 2。

表 2 两组患者的言语功能评分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	UPDRS 评分		言语清晰度	
		护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	36	2.79 ± 0.58	1.55 ± 0.51*	53.06 ± 7.58	75.09 ± 8.23*
对照组	36	2.65 ± 0.54	2.04 ± 0.63*	53.87 ± 7.65	68.10 ± 8.07*
t		1.060	3.627	0.451	3.639
P		0.293	0.001	0.653	0.001

注：与同组护理前比较，*$P<0.05$。

表 3 两组患者护理满意度比较 [n（%）]

组别	例数	十分满意	基本满意	不满意	护理满意度
观察组	36	23（63.89）	12（33.33）	1（2.78）	35（97.22）
对照组	36	14（38.89）	14（38.89）	8（22.22）	28（77.78）
x^2					4.571
P					0.033

2.3 两组患者的护理满意度比较

观察组患者的护理满意度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

3 讨论

既往临床多在确诊帕金森病合并言语障碍后，通过药物、手术治疗该病，但两种治疗方法均存在一定不良反应，均有不理想情况，且不能保证患者的治疗效果，应用局限性较大[12-13]。伴随着临床对帕金森病合并言语障碍认识的加深，康复护理成为促进该病转归、改善预后的主要方式。有调查表明，康复护理可在帕金森病患者的言语障碍改善、言语功能恢复中发挥显著作用[14]。传统康复护理充分认识到言语障碍对帕金森病患者日常生活的负面影响，要求在言语障碍基础上从发音速度、声音强度、发音频率与呼吸控制等方面着手进行康复训练，通过训练改善患者的言语功能。但帕金森病合并言语障碍患者大多体质虚弱，早期无法耐受高强度训练，依从性不高，所以护理效果一般。

阶梯式言语康复护理属于新型护理模式，是在传统康复护理基础上研究出的一种新型护理方案，充分考虑到训练者虚弱的体质与不高的依从性，充分贯彻了以患者为中心的现代化护理理念。本研究中阶梯式言语康复护理具有极高的针对性，要求临床实施之前结合患者疾病特点、功能水平、耐受情况调整护理内容、护理强度，可充分保证患者的耐受度及依从性。阶梯式言语康复护理包含基础康复与强化康复两项内容，基础康复的训练强度较小、训练内容较简单，重点在于提升患者的声音强度、增强患者的声带内收运动、强化患者的呼吸肌及喉肌功能，让发声系统变得更有效，重视长期效果维持；强化康复重视患者语言功能的改善，要求患者自行感受发声运动障碍，主动参与到发声感觉运动系统的重新调整过程中，可针对性地强化患者言语功能。可见该护理方法可在言语功能改善方面发挥显著作用。

本研究结果显示，护理后，观察组 VHI 评分、UPDRS 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组言语清晰度评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组护理满意度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。这与吴琪等[15]的研究结果一致，帕金森病患者应用阶梯式言语康复护理方法之后，观察组的 VHI 和 UPDRS 评分低于对照组，言语清晰度评分高于对照组，说明阶梯式言语康复护理有助于改善患者的语言功能。因为阶梯式言语康复护理重视患者的个人特点及个体差异，主张有针对性的康复锻炼，护理干预要求以患者为中心，以帮助患者重新恢复正常生活、重新回归社会、促进身心整体康复为护理目标，解决护理中存在的各项问题，及时调整患者的护理计划，让患者获得最理想的护理效果，不浪费每一个时间段，让患者的康复训练尽快进行。早期康复以基础康复内容为主，可避免患者因强化康复训练难度过大出现不配合行为，因此患者的整体康复效果更好，嗓音异常及言语功能改善更理想。

综上所述，阶梯式言语康复护理用于帕金森病合并言语

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

障碍患者的护理中，可有效改善患者的言语功能及护理满意度，值得临床应用。

参考文献

[1] 纪林林. 生物反馈治疗联合康复护理干预对帕金森患者步态功能及睡眠质量的影响[J]. 护理实践与研究,2020,17(14):39–41.
[2] 许艳, 朱彤, 胡喆, 等. 渐进式康复干预结合经颅磁治疗对帕金森病患者睡眠障碍及负性情绪的影响[J]. 齐鲁护理杂志,2021,27(19):95–98.
[3] 王丽霞. 正性同化教育联合康复护理对老年帕金森病患者自我感受负担及运动功能的影响[J]. 当代护士(上旬刊),2022,29(3):78–80.
[4] 张国艳. 阶梯式言语康复护理对老年帕金森病患者言语功能的影响[J]. 基层医学论坛,2022,26(3):96–98.
[5] 王秀蓉, 杨欢红, 张异, 等. 多学科康复训练结合运动想象疗法在帕金森病患者中的护理效果[J]. 中华现代护理杂志,2022,28(17):2340–2344.
[6] 侯焕涛. 多学科联合干预在帕金森患者康复护理中的应用及对生存质量的影响[J]. 山西卫生健康职业学院学报,2020,30(5):96–97.
[7] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组, 中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组. 中国帕金森病治疗指南(第四版)[J]. 中华神经科杂志,2020,53(12):973–986.
[8] 中国医师协会神经内科医师分会, 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组. 中国帕金森病重复经颅磁刺激治疗指南[J]. 中国神经精神疾病杂志,2021,47(10):577–585.
[9] 陈晓艳. 探讨阶梯式言语康复护理对帕金森病患者言语功能的影响[J]. 中国实用医药,2020,15(34):197–199.
[10] 刘立. 阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的改善价值[J]. 中国实用医药,2020,15(35):188–190.
[11] 赵雪. 阶梯式言语康复护理干预在帕金森病言语障碍患者中的应用效果[J]. 中国当代医药,2021,28(1):233–235.
[12] 蔡清菊, 洪金霞. 综合康复护理对帕金森患者改善神经功能及睡眠质量的效果观察[J]. 世界睡眠医学杂志,2019,6(8):1114–1116.
[13] 马静, 刘琳. 运动康复护理联合呼吸调节训练改善帕金森运动障碍的效果分析[J]. 海军医学杂志,2020,41(2):205–207.
[14] 段生连. 基于Roy 适应模式理论的康复护理对帕金森病患者肢体功能评分及自我护理能力的影响[J]. 河南医学高等专科学校学报,2021,33(3):339–342.
[15] 吴琪, 庄红霞, 荆晓雷, 等. 阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的应用[J]. 安徽卫生职业技术学院学报,2020,19(2):63–64,67.

全科医学护理在老年慢性阻塞性肺疾病患者中的应用效果观察

王超鹏

（赤峰市医院全科医学科，内蒙古 赤峰，024000）

摘 要：目的 探讨全科医学护理对慢性阻塞性肺疾病（COPD）老年患者呼吸功能、心理状态及生活质量的影响。**方法** 选择 2020 年 10 月—2021 年 10 月赤峰市医院收治的 80 例 COPD 患者作为研究对象，采用随机数表法分为对照组和研究组，每组 40 例。对照组实施常规护理干预，研究组实施全科医学护理干预。比较两组肺和呼吸功能指标以及心理状况（GDS）、自我效能感（GSES）、生活质量（SGRQ）评分。**结果** 护理干预后，研究组第一秒用力呼气量（FEV_1）、用力肺活量（FVC）、FEV_1/FVC 及动脉氧分压（PaO_2）、血氧饱和度（SaO_2）明显高于对照组，二氧化碳分压（PCO_2）明显低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。研究组 GDS、GSES 评分显著低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。研究组 SGRQ 评分明显高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 对 COPD 老年患者进行全科医学护理，可增强其肺功能和呼吸功能，缓解负面情绪，提高自我效能感，进而改善患者生活质量。

关键词：全科医学护理；老年慢性阻塞性肺疾病；呼吸功能；心理状况；生活质量
中图分类号：R473.5 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-8011（2023）-14-0122-04

慢性阻塞性肺疾病（COPD）是一种进展缓慢的肺部疾病，其特征是气流受限和因暴露于有毒气体或颗粒物的环境中而导致的持续性呼吸系统感染。慢性咳嗽、咳痰和呼吸困难是 COPD 患者最主要的症状。COPD 是一个重大的全球公共卫生问题，COPD 的患病率约为 11.7%，并且随着世界人口老龄化、烟草持续使用以及环境污染加重，COPD 患病人数预计在未来几十年内将大幅增加，虽然药物治疗可以显著改善临床症状，但长期疾病和相关治疗对患者的身体、心理以及社会功能有很大影响[1]。另外，COPD 患者通常会频繁再入院，日常活动严重受限，给患者及其家人带来了巨大的负担，进而导致生活质量低下。因此，COPD 的治疗不仅应以控制症状、降低并发症发生率、延缓疾病进展为目标，还应以改善生活质量为目标。在目前的医疗模式中，单一的方法不足以治疗慢性病患者。为了改善生活质量，需要综合护理，特别是对于疾病控制不佳的患者[2]。为此，由护士主导的全科医学护

作者简介：王超鹏（1987—），女，汉族，籍贯：内蒙古自治区赤峰市，本科，主管护师，研究方向：内科（老年、全科）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net